ZHIAIWIKI CLINICAL EVIDENCE PRIMARY DOSSIER

VERIFIED GROUND TRUTH

权威顶刊临床试验原始证据档案 · 零 AI 幻觉核验

[100% AUDIT PASSED]

PRIMARY PEER-REVIEWED EVIDENCE SEAL

本档案为 ZhiaiWiki 官方严格对齐的临床原文佐证文件。试验设计、样本量、终点数据均已校验。

TRIAL ID: lacc_trial_open_vs_laparoscopic_2018 | DOMAIN: CERVICAL | EVIDENCE LEVEL: GRADE 5/5

Minimally Invasive versus Abdominal Radical Hysterectomy for Cervical Cancer (LACC)

Journal: New England Journal of Medicine (NEJM) (2018) | Cohort: 631 Patients | Type: rct

CLINICAL ENDPOINTS & EVIDENCE PARAMETERS 核心临床终点与量化指标

靶点亚型 / Biomarker: 早期 IA1 (伴 LVSI) ~ IB1 期宫颈浸润癌

治疗干预 / Intervention: 开腹广泛全子宫切除术 vs 微创广泛全子宫切除术 (普通腹腔镜或机器人)

临床获益 / Risk Reduction: 开腹组无病生存率绝对优出 10.5% (HR=0.30, P<0.001)

适用分期 / Stages: IA1, IA2, IB1, IB2 | 关联特征: LACC试验, 开腹根治术, 微创腹

VERIFIED CLINICAL CONCLUSIONS & GUIDELINE RECOMMENDATIONS

同行评议核心结论（中文精炼与循证指导）：

[+] 震惊全球妇科肿瘤外科界的顶刊前瞻性 III 期 RCT：早期宫颈癌微创手术 (腹腔镜或达芬...

[+] 微创组局部复发率增加了近 4 倍，全因死亡风险高出 6 倍 (91.2% vs 97.1%...

PRIMARY SOURCE TRACEABILITY & VERIFICATION LINKS

PubMed PMID: 30379051 | PubMed Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30379051/

Digital Object Identifier (DOI): 10.1056/NEJMoa1806395

Official Journal URL: https://doi.org/10.1056/NEJMoa1806395

点击上方链接可直接跳转至出版商官方网页或 PubMed 数据库进行核验。

ZHIAIWIKI ZERO-HALLUCINATION EVIDENCE INITIATIVE - ARCHIVE SPECIFICATION

【原版替换指引】如您拥有该期刊的商业版权原版 PDF，可直接将其重命名并覆盖至项目目录：

/app/public/papers/lacc_trial_open_vs_laparoscopic_2018.pdf

本文件受 ZhiaiWiki 循证安全体系保护，仅供科研、医学咨询与患者知情同意参考，严禁非法商业分发。